Didática Aplicada à Enfermagem

Cartilha do enfermeiro educador: fundamentos, planejamento, metodologias ativas, avaliação e educação em saúde

Bacharelado em Enfermagem · 6º semestre · 80 h/a

Para quê? O quê? Como? Como avaliar?

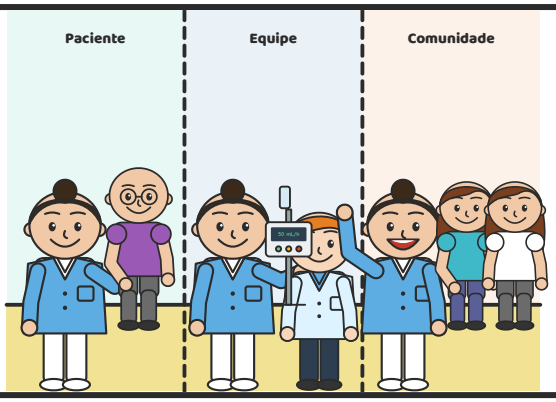


Para estudantes, enfermeiros e técnicos que ensinam

Autoria: Prof. Dr. Patrício da Silva Almeida
Síntese ilustrada do Material Didático do Discente (FTA Meta, 2026.2)

O enfermeiro é, por natureza, um educador

Ele ensina o paciente a cuidar de si, orienta a família, capacita a equipe e educa a comunidade. Cada orientação de alta, cada demonstração de técnica, cada roda de conversa é um **ato de ensino**, e ensinar bem exige método, intencionalidade e sensibilidade. A função educativa não é um adereço: está nas Diretrizes Curriculares do curso e na Lei do Exercício Profissional (Lei nº 7.498/1986).



Três cenas, um mesmo ato: orientar a aplicação de insulina, capacitar a equipe sobre um protocolo e coordenar uma roda de conversa. Em todas, o enfermeiro ensina.

CONCEITO-CHAVE

Didática é o ramo da Pedagogia que investiga e orienta o processo de ensino-aprendizagem (Libâneo: unidade entre ensino, aprendizagem e conteúdos, em contexto). Ela responde, de modo articulado, a quatro perguntas, que são o fio condutor de todo o curso e de qualquer plano de aula:

Para quê?	**O quê?**	**Como?**	**Como avaliar?**
os objetivos	os conteúdos	métodos e estratégias	a avaliação

1 · Fundamentos
12 h/a
Conceito, objeto, história e a Didática na enfermagem.

2 · Tendências e teorias
12 h/a
Tendências pedagógicas, teorias da aprendizagem, andragogia.

3 · Planejamento
16 h/a
Níveis, objetivos, Bloom, plano de ensino e de aula.

4 · Métodos e metodologias ativas
16 h/a
Técnicas, ABP, sala invertida, simulação, TDIC.

5 · Avaliação
12 h/a
Funções, instrumentos, itens, rubricas e feedback.

6 · Educação em saúde
12 h/a
Modelos, educação permanente, enfermeiro educador, ação educativa.

Como a disciplina avalia: AV1 (5,0 de atividades em sala/AVA + 5,0 de prova analítico-discursiva), AV2 (5,0 de atividades + 5,0 de prova objetiva) e AV3 (maior nota entre AV1/AV2 + maior nota entre AT1/AT2). Média final = [(AV1+AV2)/2 + AV3]/2; aprovação com 7,0. A ação educativa da Jornada Acadêmica (AV3/PROJETI) integra tudo o que está nesta cartilha.

Esta cartilha resume o Material Didático do Discente e o Plano de Disciplina de Didática Aplicada à Enfermagem (Faculdade de Tecnologia do Amapá, 2026.2). Não substitui as aulas, as leituras indicadas nem as atividades do AVA.

1 Fundamentos da Didática

Conceito, distinções, três dimensões e um pouco de história

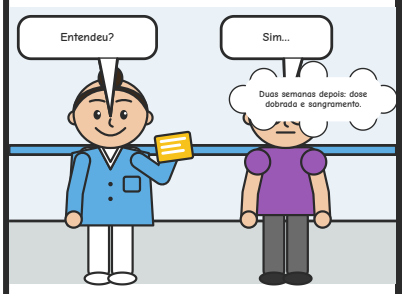
NÃO CONFUNDA

Pedagogia (ciência da educação, a mais ampla) ⊃ **Didática** (o processo de ensino) ⊃ **Metodologia** (só o "como": métodos e técnicas). **Currículo** é o conjunto de experiências do curso (PPC); **plano de ensino** detalha uma disciplina. Erro clássico de prova: tratar Didática e metodologia como sinônimos.

AS TRÊS DIMENSÕES (CANDAU)

Técnica: planejar, formular objetivos, escolher métodos, avaliar (o saber fazer). **Humana:** comunicação, acolhimento, vínculo, escuta. **Político-social:** ensinar nunca é neutro; a serviço de que projeto de saúde e de sociedade? Ignorar qualquer uma empobrece o ensino.

Marco / autor	Período	Contribuição central
Sócrates (maiêutica)	Antiguidade	Ensinar pelo diálogo e pela pergunta.
Comênio, *Didática Magna* (1632)	Séc. XVII	"Ensinar tudo a todos" (pansofia); método universal, gradual, do simples ao complexo. Pai da Didática moderna.
Herbart	Séc. XIX	Passos formais (preparação, apresentação, associação, generalização, aplicação); base da pedagogia tradicional.
Dewey / Escola Nova	Início séc. XX	Aluno no centro; "aprender fazendo". No Brasil, Manifesto dos Pioneiros (1932).
Tecnicismo	Meados séc. XX	Eficiência, objetivos operacionais, tecnologia educacional; influência behaviorista.
Didática crítica (Freire, Saviani, Libâneo, Candau)	A partir de 1980	Ensino como prática social e política; forma sujeitos críticos. Freire: contra a "educação bancária", por uma educação dialógica e problematizadora.



Estudo de caso: a orientação de alta que não funcionou

Situação: Sr. João, 68 anos, alta após evento cardíaco, em uso de anticoagulante oral. A enfermeira entregou um folheto, falou rapidamente e perguntou "entendeu?". Ele disse que sim. Duas semanas depois voltou ao pronto-socorro com sangramento: tomou dose dobrada no dia em que "esqueceu" a anterior.

Análise didática: faltou intencionalidade. Não houve objetivo observável ("o Sr. João demonstrará como proceder ao esquecer uma dose"), a estratégia era inadequada ao letramento em saúde (só fala e folheto) e a avaliação foi frágil: "entendeu?" não verifica compreensão.

Como fazer diferente: objetivo observável, demonstração com linguagem acessível e avaliação por teach-back. Isso é Didática salvando vidas.

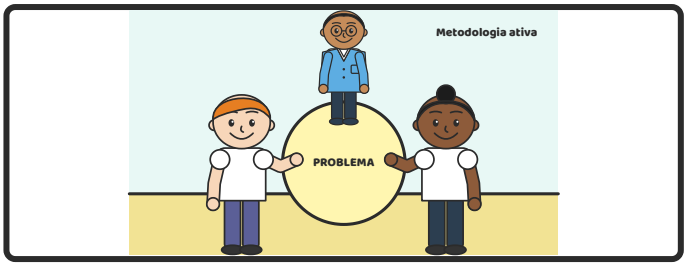
Quatro frentes da função educativa (retomadas na Unidade 6): paciente (autocuidado, adesão, alta), família e cuidador (cuidado domiciliar), equipe (protocolos, integração, educação permanente) e comunidade (promoção da saúde e prevenção).

2 Tendências pedagógicas e teorias da aprendizagem

Toda prática esconde uma teoria



Tradicional: professor no centro, transmissão e memorização; avaliação por prova que reproduz o conteúdo.



Progressistas e metodologias ativas: o aluno como sujeito, a partir de problemas reais; o professor media.

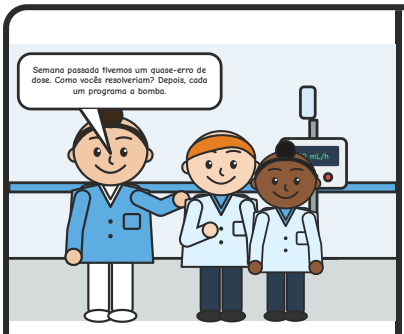
Tendência (Libâneo / Saviani)	Professor	Aluno	Avaliação
Liberal tradicional	Transmite; autoridade central	Recebe e memoriza	Provas; reprodução
Liberal renovada (Escola Nova: Dewey; não diretiva: Rogers)	Facilita a experiência	Ativo; aprende fazendo	Processual
Liberal tecnicista	Executa o planejamento	Responde a estímulos; treino	Objetiva; mede comportamentos
Progressista libertadora (Freire)	Media o diálogo; aprende junto	Sujeito; parte da própria realidade	Autoavaliação; práxis
Progressista libertária	Orienta a autogestão	Decide coletivamente	Coletiva e negociada
Crítico-social dos conteúdos (Saviani, Libâneo)	Media a apropriação do saber	Ativo e crítico	A serviço da aprendizagem significativa

TEORIAS DA APRENDIZAGEM

Behaviorismo (Skinner): estímulo, resposta e reforço; ótimo para treino psicomotor e feedback imediato, limitado para o complexo.
Construtivismo (Piaget): assimilação e acomodação; aprender é reconstruir a partir do que se sabe, com desafios na medida certa.
Sociointeracionismo (Vygotsky): Zona de Desenvolvimento Proximal; o mediador oferece "andaimes" (scaffolding) e os retira aos poucos.
Aprendizagem significativa (Ausubel): o novo se ancora em subsunçores. "O fator isolado mais importante é aquilo que o aluno já sabe."

ANDRAGOGIA (KNOWLES): COMO O ADULTO APRENDE

Autoconceito: quer autonomia, não ser tratado como criança. **Experiência:** é recurso, não obstáculo. **Prontidão:** aprende o que percebe como necessário. **Orientação:** centrada em problemas, não em conteúdos abstratos. **Motivação:** sobretudo interna. Vale para pacientes, familiares e colegas de equipe.



Estudo de caso: capacitação sobre a nova bomba de infusão

Situação: palestra unidirecional de uma hora para técnicos experientes gerou desatenção e resistência ("sempre fizemos de outro jeito").

Análise: ignorou-se a experiência dos profissionais e a orientação a problemas; o formato passivo contrariou o autoconceito de autonomia do adulto.

Reformulação: partir de um quase-erro real do serviço, reconhecer a experiência da equipe, prática supervisionada com a bomba (behaviorismo) e discussão em grupo (Vygotsky).

Pegadinha: ancore-se nos centros: tradicional → professor; renovada e progressistas → aluno/sujeito; tecnicista → objetivos e técnica. E não confunda a renovada não diretiva (Rogers, crescimento pessoal) com a libertadora (Freire, conscientização crítica).

3 O planejamento do ensino

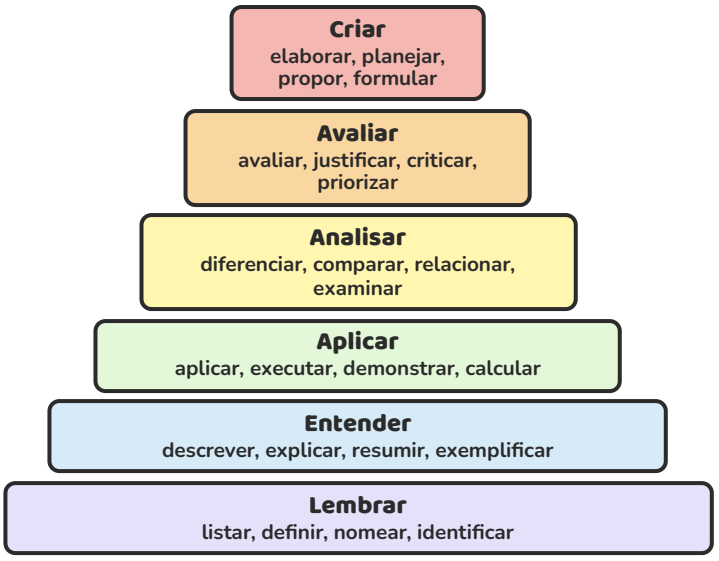
Planejar é decidir com intencionalidade (como na SAE)

NÍVEIS DE PLANEJAMENTO (DO MAIS AMPLO AO MAIS CONCRETO)

1. Educacional (políticas, Diretrizes Curriculares) → **2. Curricular** (PPC, matriz) → **3. De ensino / disciplina** (plano de ensino do semestre) → **4. Plano de aula** (um encontro).

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Descrevem o que o aluno será capaz de **fazer**. Claros, observáveis, mensuráveis, iniciados por verbo de ação. Evite "saber", "compreender bem", "ter noção". Em vez de "o aluno saberá sobre feridas": "o aluno **classificará** as lesões por pressão segundo os estágios".



Taxonomia de Bloom revisada (Anderson e Krathwohl, 2001): domínio cognitivo, do mais simples ao mais complexo.

Cognitivo
Saber e saber pensar (6 níveis acima). Ex.: "explicará as indicações e complicações da punção venosa".

Afetivo (Krathwohl)
Receber → responder → valorizar → organizar → caracterizar. Ex.: "valorizará a comunicação e o conforto do paciente".

Psicomotor
Da percepção e imitação à precisão e naturalização. Ex.: "executará a punção com técnica asséptica, conforme checklist".

PLANO DE ENSINO (DISCIPLINA)

Identificação · **Ementa** (síntese oficial e fixa) · Objetivos geral e específicos · Conteúdo programático (varia a cada oferta) · Procedimentos metodológicos · Recursos · Sistemática de avaliação (AV1, AV2, AV3) · Referências (ABNT).

PLANO DE AULA (UM ENCONTRO)

Tema e público · Objetivos (verbos de Bloom) · Conteúdo · **Desenvolvimento em três momentos**: introdução (problematização, conhecimentos prévios), desenvolvimento (exposição, atividade, prática) e fechamento (síntese) · Recursos · Tempo · Avaliação · Referências.



Plano de aula comentado (30 min): higienização das mãos para acompanhantes

Objetivo: o acompanhante demonstrará corretamente os cinco momentos da higienização das mãos (aplicar / psicomotor).

Introdução (5 min): "Em quais momentos você acha que precisa lavar as mãos aqui no hospital?" (ativa conhecimentos prévios, Ausubel). **Desenvolvimento (18 min):** exposição dialogada dos cinco momentos da OMS, demonstração e prática supervisionada com feedback (behaviorismo). **Fechamento (4 min):** síntese e ligação com a segurança do paciente.

Avaliação (3 min): cada acompanhante executa a técnica; o enfermeiro observa por checklist (teach-back prático).

Selecionar conteúdos: validade (leva ao objetivo?), relevância (é essencial?), significância (conecta ao que já sabe?) e adequação ao tempo e ao nível. Mais vale o essencial aprofundado do que "ensinar tudo".

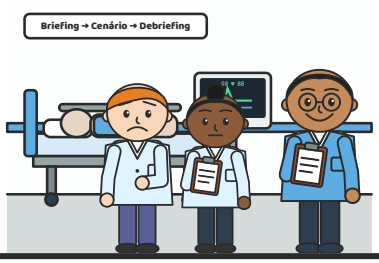
4 Métodos, técnicas e metodologias ativas

O método a serviço do objetivo, nunca o contrário

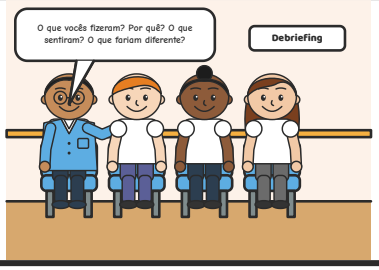
CONCEITO-CHAVE

Método = caminho/estratégia geral (expositivo, problematização, projetos). **Técnica** = procedimento que realiza o método (estudo de caso, dramatização, tempestade de ideias). **Recurso** = meio material ou digital de apoio (cartaz, manequim, vídeo, AVA). Um método admite várias técnicas; uma técnica, vários recursos.

Técnica	Para que serve	Cuidados / limites
Aula expositiva dialogada	Apresentar conteúdo com participação	Evitar monólogo; provocar interação
Estudo de caso	Aproximar teoria e prática; raciocínio clínico	Casos realistas, alinhados ao objetivo
Dramatização (role-play)	Treinar comunicação e atitudes	Debriefing para extrair aprendizados
Demonstração	Ensinar procedimentos (psicomotor)	Seguir de prática supervisionada
Roda de conversa · seminário · estudo dirigido · mapa conceitual	Troca de saberes; pesquisa e comunicação; estudo autônomo; organizar conceitos	Mediar a participação; critérios claros; boas questões; ensinar a construir o mapa



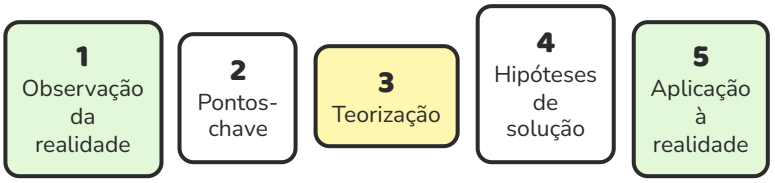
Simulação clínica: briefing → cenário → debriefing. Fidelidade baixa, média ou alta. O aprendizado não está no manequim, está no debriefing.



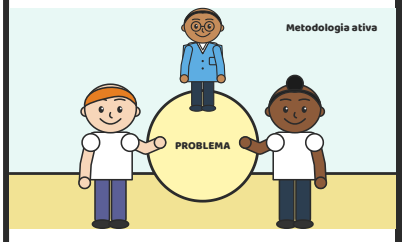
Debriefing: reflexão estruturada após o cenário: o que fizemos, por quê, o que sentimos, como melhorar. Simulação sem debriefing perde quase todo o valor.

METODOLOGIAS ATIVAS

ABP/PBL: pequenos grupos partem de um problema (caso), definem o que precisam aprender, estudam e voltam para resolver, com tutor. **Sala de aula invertida:** primeiro contato antes da aula (vídeo, leitura, AVA); o tempo em sala é para aplicar, discutir e tirar dúvidas. **TBL, gamificação, TDIC:** a escolha é sempre pela adequação ao objetivo, ao público e ao contexto; um cartaz pode superar um aplicativo para um idoso com baixo letramento digital.



Arco de Maguerez (difundido por Bordenave): a problematização parte da realidade e retorna a ela.



Estudo de caso: redesenhando a aula de parada cardiorrespiratória

Situação: aula expositiva de duas horas sobre PCR e RCP; os alunos "sabiam a teoria", mas travavam no estágio. **Diagnóstico:** o objetivo era aplicar, mas o método só mobilizava lembrar e entender. Faltou coerência método-objetivo.

Redesenho: (1) sala invertida com vídeo e diretrizes; (2) estudo de caso rápido para decisão; (3) simulação de PCR em manequim, em equipe; (4) debriefing estruturado.

Para habilidade psicomotora (ex.: curativo) a sequência é: demonstração → prática supervisionada com feedback → avaliação por checklist. Não confunda simulação (cenário completo com decisão) com demonstração de técnica isolada.

5 Avaliação da aprendizagem

Avaliar para aprender, não só para classificar

AVALIAR ≠ MEDIR

Medir é atribuir uma nota. **Avaliar** é coletar informações, julgá-las por critérios e **decidir**: sobre o aluno (recuperar, avançar) e sobre o próprio ensino (rever a estratégia). Luckesi: o **exame** é pontual, classificatório e seletivo; a **avaliação** é processual, diagnóstica e inclusiva.

TRÊS FUNÇÕES (GUARDE AS ÂNCORAS TEMPORAIS)

Diagnóstica = antes: "de onde partimos?" **Formativa = durante:** "como estamos indo?", regula pelo feedback, é a que mais impacta a aprendizagem. **Somativa = ao final:** "o que foi alcançado?", gera nota e certificação. Um mesmo instrumento pode servir a funções diferentes.

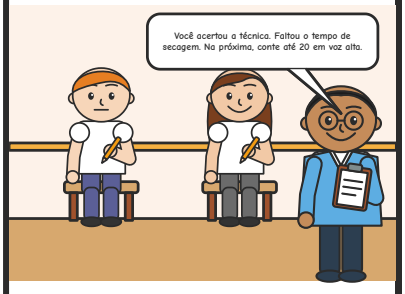
Instrumento	Avalia bem	Cuidados
Prova objetiva (múltipla escolha)	Amplitude de conteúdo; vários níveis cognitivos	Bons itens; sem ambiguidade e pegadinhas
Questão dissertativa	Argumentação, análise, síntese	Critérios definidos; rubrica
OSCE / checklist de habilidades	Desempenho psicomotor e clínico	Estações padronizadas; critérios observáveis
Estudo de caso / situação-problema	Raciocínio clínico e decisão	Casos realistas e bem estruturados
Seminário · portfólio · autoavaliação	Pesquisa e comunicação; processo e reflexão; metacognição	Critérios claros e coavaliação; feedback contínuo; combinar com outros

QUALIDADE DO INSTRUMENTO

Validade: mede o que se propõe (uma prova de punção avalia punção, não caligrafia). **Fidedignidade:** consistência; a correção não varia com o humor do avaliador. Rubricas e critérios explícitos aumentam a fidedignidade; o alinhamento aos objetivos aumenta a validade. **Praticabilidade:** viável no tempo disponível.

BONS ITENS DE MÚLTIPLA ESCOLHA

Enunciado claro, de preferência a partir de um caso clínico; **uma única** resposta correta; **distratores plausíveis** (erros que um aluno mal preparado cometeria); alternativas homogêneas; sem "todas/nenhuma das anteriores" nem absolutos ("sempre", "nunca"); cada item alinhado a um objetivo e a um nível de Bloom.



Estudo de caso: a prova que não avaliava o objetivo

Situação: o objetivo da aula era executar a técnica de curativo (psicomotor); a prova só pedia definições ("o que é técnica asséptica?"). **Problema de validade:** mediu lembrar e entender, não aplicar. Dava para acertar a prova sem saber fazer o curativo, e vice-versa.

Correção: checklist de observação (OSCE) durante a execução supervisionada, com rubrica.

Feedback em três tempos: reconhecer o que foi bem, apontar o ponto a melhorar, sugerir como melhorar. Específico, oportuno, orientado ao futuro e respeitoso.

Pegadinha: diagnóstica = antes; formativa = durante; somativa = ao final. Validade é "medir o que se propõe"; fidedignidade é "resultados consistentes". Distrator é a alternativa incorreta, porém plausível.

6 Educação em saúde e o enfermeiro educador

A síntese de tudo: empoderamento e autonomia

MODELO TRADICIONAL (PREVENTIVO / PRESCRITIVO)

Vertical e unidirecional: o profissional "detém o saber" e prescreve; a população recebe. Culpabiliza o indivíduo ("não se cuida") e ignora determinantes sociais. É a educação bancária no campo da saúde. Limitado para mudanças duradouras.

MODELO DIALÓGICO (FREIRE)

Horizontal e participativo: parte dos saberes e da realidade das pessoas, reconhece-as como sujeitos, problematiza e corresponsabiliza. Recomendado pela Política Nacional de Promoção da Saúde e pela Política Nacional de Educação Popular em Saúde.

Aspecto	Educação continuada	Educação Permanente em Saúde (EPS)
Ponto de partida	Temas e atualizações pré-definidos	Problemas reais do processo de trabalho
Periodicidade e foco	Pontual, episódica (cursos); individual	Contínua, no cotidiano; coletiva (equipe e serviço)
Concepção e objetivo	Transmissão; atualizar conhecimentos	Problematização e reflexão sobre a prática; transformar as práticas e o serviço

SAIBA MAIS

PNEPS: Portaria GM/MS nº 198/2004, reformulada pela Portaria nº 1.996/2007. **Quadrilátero da formação:** ensino, gestão, atenção e controle social. **Letramento em saúde:** capacidade de obter, compreender e usar informações de saúde; baixo letramento associa-se a pior adesão. Use frases curtas, imagens, sem jargão, e confirme com **teach-back**.

ROTEIRO DA AÇÃO EDUCATIVA (APÊNDICE C)

1 Diagnóstico da situação (Freire, Ausubel) · **2** Objetivos (verbos de Bloom) · **3** Conteúdo essencial · **4** Estratégia e metodologia · **5** Recursos e linguagem (letramento) · **6** Execução dialógica (andragogia) · **7** Avaliação (teach-back e indicadores) · **8** Registro, para a continuidade e a educação permanente.



Estudo de caso: grupo de hipertensos na Atenção Primária

Diagnóstico: muitos usuários abandonam a medicação por não sentirem sintomas e por crenças ("pressão alta é do nervoso e passa"). **Objetivo:** ao final, os participantes explicarão por que manter o tratamento mesmo sem sintomas e identificarão sinais de alerta.

Estratégia: roda de conversa dialógica partindo das experiências do grupo, com cartaz ilustrado adequado ao letramento. **Execução:** valorização das falas; desmistificação a partir do que trazem.

Avaliação: teach-back ao final e acompanhamento da adesão e da pressão arterial nas consultas seguintes.

Os quatro âmbitos do enfermeiro educador: paciente (autocuidado, adesão, alta, dispositivos, sinais de alerta), família e cuidador (cuidado domiciliar, condições crônicas, paliativos), equipe (integração, protocolos, EPS, segurança do paciente) e comunidade (promoção, prevenção, grupos, campanhas, ações intersetoriais).

Caixa de Ferramentas

Modelos dos apêndices, prontos para usar na prova, no estágio e na ação educativa

Recorte e use

Plano de aula (Apêndice B)

Tema: _____

Público-alvo: _____ Duração: _____

Objetivos (verbo de Bloom + desempenho observável):

_____

Conteúdo essencial:

_____

Introdução (___ min): pergunta disparadora / conhecimentos prévios

_____

Desenvolvimento (___ min): exposição dialogada, demonstração, prática, discussão

_____

Fechamento (___ min): síntese e amarração

_____

Recursos: _____

Avaliação (como verificar o objetivo):

_____

Verbos para objetivos (Apêndice E)

Lembrar: listar · definir · nomear · identificar · reconhecer

Entender: descrever · explicar · resumir · exemplificar · interpretar · classificar

Aplicar: aplicar · executar · demonstrar · calcular · implementar · resolver

Analisar: diferenciar · comparar · relacionar · examinar · organizar · distinguir

Avaliar: avaliar · justificar · criticar · defender · priorizar · recomendar

Criar: elaborar · planejar · propor · formular · construir · projetar

Afetivo: aceitar · participar · valorizar · respeitar · cooperar · comprometer-se

Psicomotor: executar · manusear · posicionar · montar · ajustar · realizar (procedimento)

⚠ **Evite:** saber, compreender bem, entender, conhecer, ter noção. Não são observáveis nem mensuráveis.

Rubrica de avaliação (Apêndice D): seminário ou ação educativa

Critério	Insuficiente (0–4)	Adequado (5–7)	Excelente (8–10)
Domínio do conteúdo	Erros conceituais graves	Conteúdo correto, com lacunas	Correto, aprofundado e atualizado
Organização	Sem estrutura clara	Estrutura razoável	Introdução, desenvolvimento e fechamento claros
Adequação ao público	Linguagem inadequada	Parcialmente adequada	Linguagem e recursos plenamente adequados
Interação / participação	Não promove participação	Promove alguma participação	Promove diálogo e participação efetiva
Uso do tempo e recursos	Descontrolado	Aceitável	Uso eficiente do tempo e dos recursos

Roteiro da ação de educação em saúde (Apêndice C): checklist

- ☐ 1. Diagnóstico: quem é o público, o que sabe e acredita, barreiras e letramento
- ☐ 2. Objetivos com verbos observáveis
- ☐ 3. Conteúdo essencial (o mínimo indispensável)
- ☐ 4. Estratégia adequada ao objetivo e ao público
- ☐ 5. Recursos e linguagem simples, imagens, culturalmente pertinentes
- ☐ 6. Execução dialógica: partir da realidade, valorizar as falas, problematizar
- ☐ 7. Avaliação: teach-back e indicadores (adesão, retorno, parâmetros)
- ☐ 8. Registro: participantes, temas, encaminhamentos

Modelos adaptados dos Apêndices B, C, D e E do Material Didático do Discente · Autoria: Prof. Dr. Patrício da Silva Almeida

Pegadinhas de prova e glossário

O que as bancas mais cobram

Didática ≠ metodologia. A metodologia é só o "como"; a Didática também abrange objetivos, conteúdos e avaliação. Pedagogia ⊃ Didática ⊃ metodologia.

Comênio é o pai da Didática moderna (*Didática Magna*, 1632). **Herbart**: passos formais e pedagogia tradicional. **Dewey**: Escola Nova, aprender fazendo. **Freire**: contra a educação bancária.

Piaget: assimilação e acomodação. **Vygotsky**: ZDP e scaffolding. **Ausubel**: subsunçores e aprendizagem significativa. **Skinner**: reforço. **Knowles**: andragogia.

Níveis de planejamento, do mais amplo ao mais específico: educacional → curricular → de ensino → de aula. Ementa é fixa e sintética; o conteúdo programático varia.

Bloom revisado: lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar, **criar** (o mais complexo). Três domínios: cognitivo, afetivo e psicomotor. "Demonstrar a técnica" é psicomotor.

Método é o caminho; **técnica** é o procedimento; **recurso** é o meio. O princípio que orienta a escolha: adequação ao objetivo, ao público e ao contexto.

Simulação: briefing → cenário → **debriefing** (o momento central). **Sala invertida**: contato prévio antes; sala para aplicar. **ABP**: parte de problemas, com tutoria. **Arco de Maguerez**: 5 etapas, parte e retorna à realidade.

Avaliação: diagnóstica (antes), formativa (durante, feedback), somativa (ao final). Validade = mede o que se propõe; fidedignidade = consistência. Luckesi: avaliação ≠ exame.

Educação continuada é pontual e temática; **EPS** parte dos problemas reais do trabalho e transforma as práticas (PNEPS, Portaria 198/2004 e 1.996/2007; quadrilátero: ensino, gestão, atenção, controle social).

Teach-back: pedir que a pessoa repita ou execute com as próprias palavras. **Letramento em saúde**: obter, compreender e usar informações de saúde. Primeira etapa da ação educativa: **diagnóstico da situação**.

Glossário rápido

Andragogia: especificidades da aprendizagem do adulto (Knowles).
Currículo: conjunto organizado de experiências de aprendizagem de um curso.
Debriefing: reflexão estruturada após a simulação.
Distrator: alternativa incorreta, porém plausível, de um item.
Educação bancária: crítica de Freire ao ensino que "deposita" conteúdos.
Ementa: síntese oficial do conteúdo de uma disciplina.
Empoderamento: ampliação da autonomia e do poder de decisão sobre a saúde.
Feedback: devolutiva que orienta a melhoria da aprendizagem.
Maiêutica: método socrático de ensinar por perguntas.
Organizador prévio: ponte entre o que o aluno sabe e o novo (Ausubel).
Pansofia: ideal comeniano de "ensinar tudo a todos".
Rubrica: matriz de critérios e níveis de desempenho.
Scaffolding: apoios temporários ("andaimes") do mediador.
Subsunçor: conhecimento prévio que ancora o novo (Ausubel).
TDIC: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.
ZDP: distância entre o que se faz sozinho e com ajuda (Vygotsky).

Referências básicas da disciplina: LIBÂNEO, J. C. *Didática* (Cortez, 2013); MASETTO, M. T. *Competência pedagógica do professor universitário* (Summus, 2015); BORDENAVE, J. E. D.; PEREIRA, A. M. *Estratégias de ensino-aprendizagem* (Vozes, 2015). Complementares: FREIRE, P. *Pedagogia da autonomia* (Paz e Terra, 2011); ANASTASIOU, L. G. C.; ALVES, L. P. *Processos de ensinagem na universidade* (Univille, 2004); REIBNITZ, K. S.; PRADO, M. L. *Inovação e educação em enfermagem* (Cidade Futura, 2006).

Mini-simulado

Doze questões selecionadas das questões de fixação da apostila. Marque, depois confira o gabarito.

AV1 · AV2

1. O objeto de estudo da Didática é:
a) a administração financeira das instituições de ensino. b) o processo de ensino, na unidade entre ensino, aprendizagem e conteúdos, em seu contexto. c) exclusivamente a elaboração de provas. d) a gestão hospitalar. e) a história geral da humanidade.

2. A dimensão do processo didático referente à relação interpessoal, comunicação e acolhimento é a:
a) técnica. b) humana. c) político-social. d) burocrática. e) financeira.

3. A crítica à "educação bancária" e a defesa de uma educação dialógica são atribuídas a:
a) Comênio. b) Herbart. c) Skinner. d) Paulo Freire. e) Quintiliano.

4. O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal está associado a:
a) Skinner e o reforço. b) Vygotsky e a mediação social. c) Ausubel e os subsunçores. d) Piaget e a acomodação. e) Knowles e a andragogia.

5. Princípio da andragogia (Knowles):
a) o adulto aprende melhor quando tratado como criança. b) a experiência prévia é irrelevante. c) o adulto aprende melhor de forma centrada em problemas reais. d) a motivação é exclusivamente externa. e) prefere conteúdos abstratos.

6. Na Taxonomia de Bloom revisada (domínio cognitivo), o nível mais complexo é:
a) lembrar. b) entender. c) aplicar. d) analisar. e) criar.

7. Objetivo bem formulado (observável e mensurável):
a) "o aluno compreenderá bem as feridas". b) "o aluno terá noção de curativos". c) "o aluno classificará as lesões por pressão segundo os estágios". d) "o aluno saberá sobre feridas". e) "o aluno conhecerá a técnica".

8. A sequência correta dos níveis de planejamento, do mais amplo ao mais específico:
a) aula → ensino → curricular → educacional. b) educacional → curricular → de ensino → de aula. c) curricular → educacional → de aula → de ensino. d) de ensino → de aula → curricular → educacional. e) de aula → curricular → educacional → de ensino.

9. Na simulação clínica, o momento reflexivo após o cenário denomina-se:
a) briefing. b) cenário. c) debriefing. d) checklist. e) fidelidade.

10. A avaliação realizada durante o processo, cuja finalidade principal é fornecer feedback e regular a aprendizagem, é a:
a) diagnóstica. b) somativa. c) formativa. d) classificatória. e) seletiva.

11. Um instrumento é considerado válido quando:
a) é fácil de corrigir. b) mede aquilo que se propõe a medir. c) produz resultados consistentes em aplicações repetidas. d) usa apenas múltipla escolha. e) é longo e detalhado.

12. A diferença essencial entre educação continuada e educação permanente é que a EPS:
a) é pontual e episódica. b) parte de temas pré-definidos. c) parte dos problemas reais do trabalho e busca transformar as práticas. d) tem foco individual. e) limita-se a cursos de atualização.

Gabarito: 1-b · 2-b · 3-d · 4-b · 5-c · 6-e · 7-c · 8-b · 9-c · 10-c · 11-b · 12-c. Errou alguma? Volte à unidade correspondente e releia o conceito-chave: é assim que a avaliação vira aprendizagem (função formativa).

Discursivas para treinar (AV1)

- Explique, com um exemplo da prática de enfermagem, por que "o cuidado de enfermagem é também um ato educativo".
- Elabore um plano de aula resumido (tema, objetivos com verbos de Bloom, três momentos e avaliação) para a orientação de alta de um paciente em uso de anticoagulante.
- Explique por que o debriefing é o momento central da simulação e descreva como o conduziria após um cenário de PCR.
- Compare os modelos tradicional e dialógico de educação em saúde e explique por que o dialógico tende a ser mais eficaz.

Roteiro de estudo (da apostila)

Antes da aula: leia a introdução e os objetivos da unidade.
Durante a leitura: grife os conceitos-chave e registre dúvidas.
Depois da aula: refaça os estudos de caso e as questões de fixação; confira o gabarito comentado.
Na revisão: releia as sínteses, o glossário e o banco de questões (Apêndice G) e os simulados.



"A competência didática, como toda competência clínica, se constrói com estudo e prática."